

Documentation-Driven Threat Analysis

DermaTriage Case Study

Documentation + Base Analysis

Documentazione gerarchica DDTA del progetto DermaTriage

La documentazione di progetto occupa circa due terzi della pagina; la Base Analysis occupa il terzo laterale e viene avviata progressivamente distinguendo elementi candidati da elementi stabili / accettati. La documentazione e' ordinata gerarchicamente: MacroRequirement, quindi le sue Decision e, immediatamente sotto ogni Decision, i relativi FunctionalRequirement.

Struttura del case study

La lettura segue sempre il containment documentale: MR → Decision → FR. Non vengono raccolte prima tutte le Decision e poi tutti gli FR. Ogni FR descrive direttamente il funzionamento e l'implementazione corrente di DermaTriage; i riquadri grigi sono riservati esclusivamente a domande e richieste di chiarimento. Nella colonna Base Analysis, il corsivo identifica elementi ancora candidati; il grassetto e' riservato agli elementi entrati nella baseline BA stabile / accettata.

1 Contesto generale del progetto

Documentazione DDTA

Project Problem Framing

Il problema che DermaTriage deve affrontare e' il supporto al triage precoce di casi dermatologici relativi a lesioni potenzialmente oncologiche. Il progetto parte dalle informazioni gia' disponibili sul caso per determinarne l'urgenza e una priorita' operativa di presa in carico, con l'obiettivo di favorire un instradamento specialistico tempestivo.

Base Analysis

Convenzione di stato BA

La tipografia indica lo stato di authoring, non il tipo semantico. Un elemento in *corsivo* e' ancora candidato e puo' essere modificato, unito, separato o scartato. Solo dopo review entra nel riquadro stabile e viene mostrato in **grassetto**. La presenza ripetuta nella documentazione non costituisce da sola accettazione.

Lettura del Project Problem Framing

Il Problem Framing contribuisce gia' alla Base Analysis: introduce significati che ricompaiono nei livelli documentali successivi. Non li materializziamo tutti automaticamente. In questo primo passaggio applichiamo soltanto identity test e assertion test; la scelta degli operatori resta intenzionalmente rinviata.

Candidati BA - in revisione

Identita' candidate

DermaTriage; DermatologicalCase; CaseUrgency; OperationalTriagePriority; DermatologicalTriageEvaluation; AvailableCaseInformation.

Asserzioni candidate, ancora senza operatore

*la valutazione di triage usa le informazioni disponibili sul caso;
la valutazione di triage determina l'urgenza del caso;
la valutazione di triage determina la priorita' operativa del caso.*

Non materializzati per ora

Potenziale natura oncologica della lesione, supporto al triage precoce e instradamento specialistico tempestivo restano significati da riesaminare; in questo passaggio non ricevono identita' BA autonoma.

BA stabile / accettata

Nessun BAReferent o BAProposition e' ancora stato accettato in questo scope. Il riquadro verra' popolato soltanto dopo la review dei candidati.

2 MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico

Documentazione DDTA

MacroRequirement

Intent

Determinare, a partire dalle informazioni disponibili sul caso dermatologico, l'urgenza del caso e la relativa priorit  operativa di triage.

Context

La valutazione di triage utilizza le informazioni disponibili sul caso dermatologico. La disponibilit  e la tipologia delle evidenze possono variare tra i casi.

Stakeholders

Paziente.

Scope

IN: determinazione dell'urgenza del caso e della relativa priorit  operativa di triage a partire dalle informazioni di caso governate dal progetto.

OUT: indicazione della destinazione specialistica; validazione o correzione medica dell'esito; adattamento successivo del comportamento del sistema sulla base della revisione clinica.

Assumptions / Constraints

–

dependsOn

None

Domande / chiarimenti richiesti

- HIGH / MEDIUM / LOW e' una convenzione governata autonomamente o un vocabolario downstream usato coerentemente?
- I percorsi diretto e B4-integrato sono due strategie che il progetto intende preservare oppure due interfacce della realizzazione corrente?
- Il recupero di casi storici ha governance autonoma oppure e' comportamento interno della pipeline image-based?

Base Analysis

Stato dell'analisi

L'analisi BA di questo elemento documentale non e' ancora stata eseguita. I candidati emersi nelle pagine precedenti restano candidati: questo elemento potra' confermarli, modificarli, separarli o far emergere nuovi significati, ma non li promuove automaticamente.

Candidati BA - in revisione

Da popolare quando questo elemento verra' analizzato.

BA stabile / accettata

Nessuna nuova accettazione in questo passaggio.

2.1 DEC-MR01-01 - Triage in assenza di immagine

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-01

Documentazione DDTA

Decision
Parent MR MR-01 Context Un caso dermatologico può avere un'immagine della lesione, oppure no. Decision DermaTriage valuta il triage anche se manca l'immagine della lesione. In quel caso usa le informazioni sui sintomi disponibili sul caso. Consequences Se l'immagine manca, il triage si può comunque fare. Il percorso basato sui sintomi può usare informazioni diverse; non deve per forza dare gli stessi risultati del percorso con immagine.
Domande / chiarimenti richiesti
• Che cosa costituisce esattamente una immagine assente o non disponibile? • Quali informazioni sintomatologiche minime devono essere disponibili? • E' richiesta equivalenza di output fra percorso con immagine e percorso senza immagine?

Base Analysis

Stato dell'analisi
L'analisi BA di questo elemento documentale non e' ancora stata eseguita. I candidati emersi nelle pagine precedenti restano candidati: questo elemento potra' confermarli, modificarli, separarli o far emergere nuovi significati, ma non li promuove automaticamente.
Candidati BA - in revisione
Da popolare quando questo elemento verra' analizzato.
BA stabile / accettata
Nessuna nuova accettazione in questo passaggio.

2.1.1 FR-MR01-01-01 - Continuita' del triage symptom-only

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-01 → FR-MR01-01-01

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-01-01
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Continuita' del triage symptom-only
Parent Decision	DEC-MR01-01
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Quando l'immagine della lesione non e' disponibile, DermaTriage usa un percorso *symptom-only* per determinare l'urgenza a partire dalle informazioni sintomatologiche disponibili sul caso. Nel workflow B4-integrated tali informazioni comprendono campi sintomatologici quali itching, bleeding, growth/change e pain.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

1. Quando l'immagine della lesione non e' disponibile, DermaTriage MUST continuare la valutazione di triage mediante il percorso *symptom-only*.

2. Il percorso *symptom-only* MUST determinare l'urgenza usando le informazioni sintomatologiche disponibili sullo stesso caso.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

-

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

• Qual e' l'insieme completo dei sintomi supportati dal percorso symptom-only?

• Come vengono gestiti campi sintomatologici mancanti, non validi o parziali?

• Qual e' la regola completa di symptom scoring che produce l'urgenza?

Base Analysis

Stato dell'analisi

L'analisi BA di questo elemento documentale non e' ancora stata eseguita. I candidati emersi nelle pagine precedenti restano candidati: questo elemento potra' confermarli, modificarli, separarli o far emergere nuovi significati, ma non li promuove automaticamente.

Candidati BA - in revisione

Da popolare quando questo elemento verra' analizzato.

BA stabile / accettata

Nessuna nuova accettazione in questo passaggio.

2.2 DEC-MR01-02 - Scala di priorit  P1-P4

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-02

Documentazione DDTA

Decision

Parent MR
MR-01

Context
Il triage deve indicare anche una priorit  operativa per la presa in carico del caso.

Decision
DermaTriage usa la scala P1-P4 per rappresentare la priorit  operativa di triage.

Consequences
La priorit  operativa   uno dei livelli P1, P2, P3 o P4. Le regole per assegnare il livello a un caso sono definite a parte.

Domande / chiarimenti richiesti

- Qual e' la regola completa che mappa urgenza e confidence sulla P-scale?
- La soglia di confidence e' un parametro configurabile o una regola governata?
- I valori temporali associati a P1-P4 sono SLA normativi, target o semplici valori documentati?
- Chi governa l'eventuale trigger e l'owner degli SLA?

Base Analysis

Stato dell'analisi

L'analisi BA di questo elemento documentale non e' ancora stata eseguita. I candidati emersi nelle pagine precedenti restano candidati: questo elemento potra' confermarli, modificarli, separarli o far emergere nuovi significati, ma non li promuove automaticamente.

Candidati BA - in revisione

Da popolare quando questo elemento verra' analizzato.

BA stabile / accettata

Nessuna nuova accettazione in questo passaggio.

2.2.1 FR-MR01-02-01 - Dominio della priorit  P1-P4

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-02 → FR-MR01-02-01

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-02-01
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Dominio della priorit� P1-P4
Parent Decision	DEC-MR01-02
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

DermaTriage rappresenta ogni priorit  operativa di triage mediante uno dei quattro valori P1, P2, P3 o P4.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

Quando DermaTriage produce una priorit  operativa di triage, il valore MUST appartenere all'insieme {P1, P2, P3, P4}.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

–

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

- I valori 24h / 48h / 72h / 7 giorni sono SLA normativi, target operativi o valori della configurazione corrente?
- Quale evento fa partire il tempo associato alla priorit  e chi ne   owner?

Base Analysis

Stato dell'analisi

L'analisi BA di questo elemento documentale non   ancora stata eseguita. I candidati emersi nelle pagine precedenti restano candidati: questo elemento potr  confermarli, modificarli, separarli o far emergere nuovi significati, ma non li promuove automaticamente.

Candidati BA - in revisione

Da popolare quando questo elemento verra' analizzato.

BA stabile / accettata

Nessuna nuova accettazione in questo passaggio.

2.3 DEC-MR01-03 - Pipeline analitica a quattro stadi

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03

Documentazione DDTA

Decision
Parent MR MR-01 Context Se c'è un'immagine della lesione, la valutazione di triage combina più passaggi analitici prima di arrivare a una sintesi del caso. Decision DermaTriage realizza il percorso basato sull'immagine con una pipeline sequenziale a quattro stadi. I risultati dei primi stadi alimentano le elaborazioni successive, fino alla sintesi di triage. Consequences Il percorso analitico resta una sequenza di quattro stadi. Le tecnologie e i modelli dentro i singoli stadi possono cambiare o evolvere senza per forza modificare questa struttura.
Domande / chiarimenti richiesti
- E' governato il numero esatto di quattro stadi o soltanto la separazione delle funzioni analitiche? - L'ordine degli stadi e' un commitment stabile oppure una proprieta' della realizzazione corrente? - Quali responsabilita' appartengono alla Decision e quali restano comportamento interno dei singoli stadi?

Base Analysis

Stato dell'analisi
L'analisi BA di questo elemento documentale non e' ancora stata eseguita. I candidati emersi nelle pagine precedenti restano candidati: questo elemento potra' confermarli, modificarli, separarli o far emergere nuovi significati, ma non li promuove automaticamente.
Candidati BA - in revisione
Da popolare quando questo elemento verra' analizzato.
BA stabile / accettata
Nessuna nuova accettazione in questo passaggio.

2.3.1 FR-MR01-03-01 - Stage 1: urgenza e confidence da immagine

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-01

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-03-01
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Stage 1: urgenza e confidence da immagine
Parent Decision	DEC-MR01-03
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Nel percorso image-based, lo Stage 1 usa un modello EfficientNet-B4 fine-tuned per elaborare immagini RGB a 380x380 e produrre un valore di urgenza HIGH / MEDIUM / LOW con confidence associata. La classificazione HIGH usa una soglia pari a 0.25. Il risultato resta distinto dalla successiva priorit  operativa P1-P4.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

1. Lo Stage 1 MUST elaborare l'immagine della lesione mediante il modello EfficientNet-B4 fine-tuned su input RGB 380x380.

2. Lo Stage 1 MUST produrre un valore di urgenza appartenente a HIGH / MEDIUM / LOW e una confidence associata.

3. La classificazione HIGH MUST applicare la soglia 0.25 nella configurazione documentata.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

-

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

• La soglia 0.25   configurabile a runtime, un default oppure un valore governato e stabile?

• Qual   la regola completa che distingue MEDIUM da LOW?

• Come vengono gestite immagini assenti, non valide o non processabili nel percorso image-based?

Base Analysis

Stato dell'analisi

L'analisi BA di questo elemento documentale non   ancora stata eseguita. I candidati emersi nelle pagine precedenti restano candidati: questo elemento potr  confermarli, modificarli, separarli o far emergere nuovi significati, ma non li promuove automaticamente.

Candidati BA - in revisione

Da popolare quando questo elemento verra' analizzato.

BA stabile / accettata

Nessuna nuova accettazione in questo passaggio.

2.3.2 FR-MR01-03-02 - Stage 2: descrizione clinica strutturata

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-02

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-03-02
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Stage 2: descrizione clinica strutturata
Parent Decision	DEC-MR01-03
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Nel percorso image-based, lo Stage 2 usa Qwen2-VL-7B-Instruct come vision-language model per derivare dall'immagine della lesione una descrizione clinica testuale strutturata in cinque parti e renderla disponibile agli stadi analitici successivi.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

1. Lo Stage 2 MUST usare Qwen2-VL-7B-Instruct per elaborare l'immagine della lesione.

2. Lo Stage 2 MUST produrre una descrizione clinica testuale strutturata in cinque parti.

3. Lo Stage 2 MUST rendere la descrizione prodotta disponibile al processamento successivo della pipeline.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

-

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

• Quali sono esattamente le cinque parti richieste della descrizione clinica?

• Ordine, lingua e formato delle cinque parti sono obbligatori o modificabili?

• Qual e' il comportamento richiesto se la descrizione non puo' essere prodotta completamente?

Base Analysis

Stato dell'analisi

L'analisi BA di questo elemento documentale non e' ancora stata eseguita. I candidati emersi nelle pagine precedenti restano candidati: questo elemento potra' confermarli, modificarli, separarli o far emergere nuovi significati, ma non li promuove automaticamente.

Candidati BA - in revisione

Da popolare quando questo elemento verra' analizzato.

BA stabile / accettata

Nessuna nuova accettazione in questo passaggio.

2.3.3 FR-MR01-03-03 - Stage 3: recupero di casi storici simili

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-03

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-03-03
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Stage 3: recupero di casi storici simili
Parent Decision	DEC-MR01-03
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Lo Stage 3 usa ChromaDB e gli embedding sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 per confrontare la rappresentazione clinica del caso con i casi dermatologici storici tramite cosine similarity. Il retrieval restituisce i top-5 casi piu' simili e rende il relativo contesto disponibile allo Stage 4.

Functional clauses / inherited normativeClause

[1..*]

1.

Lo Stage 3 MUST usare ChromaDB con embedding sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 per il retrieval dei casi storici.

2.

Il confronto MUST usare la cosine similarity e MUST selezionare i top-5 casi dermatologici storici piu' simili.

3.

Lo Stage 3 MUST rendere il contesto dei casi recuperati disponibile allo Stage 4 per la sintesi multi-source.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

-

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

•

Il valore top-5 e' un requisito stabile oppure una configurazione modificabile?

•

Che cosa deve accadere quando sono disponibili meno di cinque casi utilizzabili?

•

Quali campi dei casi recuperati devono essere resi disponibili allo Stage 4?

Base Analysis

Stato dell'analisi

L'analisi BA di questo elemento documentale non e' ancora stata eseguita. I candidati emersi nelle pagine precedenti restano candidati: questo elemento potra' confermarli, modificarli, separarli o far emergere nuovi significati, ma non li promuove automaticamente.

Candidati BA - in revisione

Da popolare quando questo elemento verra' analizzato.

BA stabile / accettata

Nessuna nuova accettazione in questo passaggio.

2.3.4 FR-MR01-03-04 - Stage 4: sintesi multi-source

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-04

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-03-04
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Stage 4: sintesi multi-source
Parent Decision	DEC-MR01-03
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Lo Stage 4 usa BioMistral-7B per combinare gli output degli Stage 1, 2 e 3 con le informazioni sintomatologiche disponibili. La sintesi produce una rappresentazione JSON che contiene urgency, confidence, reasoning e pathology ed e' utilizzata dal successivo passaggio di derivazione della priorita' operativa.

Functional clauses / inherited normativeClause

[1..*]

1.

Lo Stage 4 MUST usare BioMistral-7B per eseguire la sintesi multi-source.

2.

La sintesi MUST combinare gli output disponibili degli Stage 1, 2 e 3 con le informazioni sintomatologiche del caso.

3.

Lo Stage 4 MUST produrre una rappresentazione JSON contenente urgency, confidence, reasoning e pathology, utilizzabile dal successivo passaggio operativo.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

-

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

• Qual e' il contratto completo del JSON prodotto dallo Stage 4 e quali campi sono obbligatori?

• Qual e' il significato governato del campo pathology e quali usi sono autorizzati?

• Come deve comportarsi la sintesi se uno degli input degli stadi precedenti e' assente o incompleto?

Base Analysis

Stato dell'analisi

L'analisi BA di questo elemento documentale non e' ancora stata eseguita. I candidati emersi nelle pagine precedenti restano candidati: questo elemento potra' confermarli, modificarli, separarli o far emergere nuovi significati, ma non li promuove automaticamente.

Candidati BA - in revisione

Da popolare quando questo elemento verra' analizzato.

BA stabile / accettata

Nessuna nuova accettazione in questo passaggio.

2.4 DEC-MR01-04 - Separazione tra valutazione dell’urgenza e prioritá’ operativa

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-04

Documentazione DDTA

Decision
Parent MR MR-01 Context La valutazione del caso produce prima un risultato sull’urgenza, poi una prioritá operativa per la presa in carico. Decision Nel percorso basato sull’immagine, DermaTriage tiene separata la valutazione analitica dell’urgenza dalla determinazione successiva della prioritá operativa di triage. Consequences La prioritá operativa si determina dopo la valutazione dell’urgenza, non dentro la pipeline analitica. La prioritá risultante si esprime con la scala P1-P4.
Domande / chiarimenti richiesti
• La separazione e’ un boundary architetturale intenzionale o soltanto la forma corrente della pipeline? • La prioritá operativa potrebbe essere prodotta direttamente dall’ultimo stadio senza violare un commitment documentato? • Quali semantiche appartengono al boundary e quali alla futura regola operativa di mapping?

Base Analysis

Stato dell’analisi
L’analisi BA di questo elemento documentale non e’ ancora stata eseguita. I candidati emersi nelle pagine precedenti restano candidati: questo elemento potra’ confermarli, modificarli, separarli o far emergere nuovi significati, ma non li promuove automaticamente.
Candidati BA - in revisione
Da popolare quando questo elemento verra’ analizzato.
BA stabile / accettata
Nessuna nuova accettazione in questo passaggio.

2.4.1 FR-MR01-04-01 - Mapping urgenza/confidence verso P1-P4

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-04 → FR-MR01-04-01

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement	
ID	FR-MR01-04-01
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Mapping urgenza/confidence verso P1-P4
Parent Decision	DEC-MR01-04
Owning MR (derived)	MR-01
Functional obligation L' <i>Adaptation Layer</i> deriva la priorit� operativa P1-P4 dalla valutazione analitica di urgenza e dalla confidence applicabile. Per i casi HIGH, la soglia stretta confidence > 0.85 seleziona P1; gli altri casi HIGH selezionano P2; MEDIUM seleziona P3; LOW seleziona P4.	
Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]	
Condizione	Priorita' richiesta
HIGH + confidence > 0.85	L' <i>Adaptation Layer</i> MUST produrre P1.
HIGH, negli altri casi applicabili	L' <i>Adaptation Layer</i> MUST produrre P2.
MEDIUM	L' <i>Adaptation Layer</i> MUST produrre P3.
LOW	L' <i>Adaptation Layer</i> MUST produrre P4.
Riferimenti strutturati / evidenze governate -	
SpecializedRequirement relation Nessuna relazione stabilita.	

Domande / chiarimenti richiesti

- Quando l'urgenza proviene dal percorso symptom-only, si applica lo stesso mapping verso P1-P4 oppure una regola diversa?
- I valori temporali associati a P1-P4 hanno natura normativa di SLA? Quale trigger e quale owner li governano?
- Come viene trattata una confidence assente, non valida o fuori dal dominio atteso?

Base Analysis

Stato dell'analisi
L'analisi BA di questo elemento documentale non e' ancora stata eseguita. I candidati emersi nelle pagine precedenti restano candidati: questo elemento potra' confermarli, modificarli, separarli o far emergere nuovi significati, ma non li promuove automaticamente. In particolare, il futuro passaggio BA non dovra' colmare la lacuna symptom-only verso P1-P4 e non dovra' trasformare gli SLA documentati in vincoli canonici senza una precedente chiusura della documentazione.
Candidati BA - in revisione
Da popolare quando questo elemento verra' analizzato.
BA stabile / accettata
Nessuna nuova accettazione in questo passaggio.

3 MR-02 - Indicazione della destinazione specialistica

Documentazione DDTA

MacroRequirement

Intent

Determinare un'indicazione di destinazione specialistica per il caso dermatologico, a supporto del successivo instradamento verso l'assistenza appropriata.

Context

DermaTriage associa al risultato del processo di triage un'informazione orientata alla destinazione specialistica. La documentazione disponibile non stabilisce il vocabolario delle destinazioni, la regola di selezione ne' la responsabilita' di assegnazione o prenotazione.

Stakeholders

–

Scope

IN: produzione di un'indicazione di destinazione specialistica per il caso.

OUT: prenotazione; assegnazione effettiva; tassonomia completa delle destinazioni; regola completa di selezione e fallback.

Assumptions / Constraints

–

dependsOn

None

STOP AT MR

Il significato macro e' sufficientemente distinguibile, ma la documentazione disponibile non governa commitment ulteriori sufficienti per una decomposizione fedele. Il branch si arresta intenzionalmente a MacroRequirement.

Domande / chiarimenti richiesti

- Qual e' il vocabolario governato delle destinazioni specialistiche?
- E' documentata una regola di selezione della destinazione?
- Chi possiede l'assegnazione o la prenotazione effettiva?

Base Analysis

Stato dell'analisi

L'analisi BA di questo elemento documentale non e' ancora stata eseguita. I candidati emersi nelle pagine precedenti restano candidati: questo elemento potra' confermarli, modificarli, separarli o far emergere nuovi significati, ma non li promuove automaticamente.

Il successivo passaggio analitico dovra' consumare soltanto il significato qui documentato, preservando lo STOP AT MR e senza inferire regole di selezione specialistica mancanti.

Candidati BA - in revisione

Da popolare quando questo elemento verra' analizzato.

BA stabile / accettata

Nessuna nuova accettazione in questo passaggio.

4 MR-03 - Validazione e correzione medica degli esiti

Documentazione DDTA

MacroRequirement

Intent

Consentire al medico di validare o correggere gli esiti prodotti da DermaTriage e rendere disponibile il risultato della revisione nel contesto del caso cui si riferisce.

Context

Gli esiti prodotti da DermaTriage possono essere sottoposti a revisione medica. Il medico puo' validarli o correggerli; il progetto gestisce il risultato della revisione senza includere in questa responsabilita' il successivo adattamento del sistema.

Stakeholders

Medico.

Scope

IN: gestione del risultato della validazione o correzione medica e sua associazione al caso o all'esito cui si riferisce.

OUT: meccanismi tecnici di scambio e autenticazione; adattamento successivo del comportamento del sistema sulla base delle correzioni raccolte.

Assumptions / Constraints

–

dependsOn

None

Domande / chiarimenti richiesti

- La revisione medica affianca o sostituisce l'esito originario?
- Quali parti dell'esito possono essere validate o corrette?
- Quali requisiti di correlazione tra revisione e caso sono realmente governati?

Base Analysis

Stato dell'analisi

L'analisi BA di questo elemento documentale non e' ancora stata eseguita. I candidati emersi nelle pagine precedenti restano candidati: questo elemento potra' confermarli, modificarli, separarli o far emergere nuovi significati, ma non li promuove automaticamente.

Nel passaggio successivo dovra' essere verificato quali referenti e relazioni siano realmente derivabili dal significato documentato, senza introdurre una semantica della revisione clinica non stabilita dalla documentazione.

Candidati BA - in revisione

Da popolare quando questo elemento verra' analizzato.

BA stabile / accettata

Nessuna nuova accettazione in questo passaggio.

5 MR-04 - Adattamento controllato sulla base della revisione clinica

Documentazione DDTA

MacroRequirement
Intent Consentire l’adattamento controllato del comportamento di DermaTriage utilizzando i risultati delle validazioni e correzioni mediche raccolte. Context Le correzioni mediche vengono utilizzate per modificare nel tempo il comportamento del sistema. L’evoluzione dei prompt e il riaddestramento del classificatore sono modalita’ correnti di realizzazione di questa responsabilita’ e non ne definiscono l’identita’ macro. Stakeholders Medico. Scope IN: adattamento del comportamento del sistema sulla base dei risultati della revisione medica disponibili. OUT: produzione del giudizio di validazione o correzione medica; dettagli dei singoli meccanismi di adattamento. Assumptions / Constraints – dependsOn MR-03
Domande / chiarimenti richiesti
• Quale evidenza clinica e’ sufficiente per attivare l’adattamento? • Chi autorizza l’adozione del comportamento adattato? • Quali criteri di accettazione, rollback e reversibilita’ sono governati?

Base Analysis

Stato dell’analisi
L’analisi BA di questo elemento documentale non e’ ancora stata eseguita. I candidati emersi nelle pagine precedenti restano candidati: questo elemento potra’ confermarli, modificarli, separarli o far emergere nuovi significati, ma non li promuove automaticamente. Il successivo passaggio dovra’ preservare la dipendenza semantica da MR-03 senza trasformarla in containment o co-ownership e senza promuovere automaticamente i meccanismi correnti di adattamento a responsabilita’ macro autonome.
Candidati BA - in revisione
<i>Da popolare quando questo elemento verra’ analizzato.</i>
BA stabile / accettata
Nessuna nuova accettazione in questo passaggio.

6 Indice di integrita’ delle pagine

Regola di verifica

Ogni pagina possiede un MD5 del proprio contenuto canonico. Il calcolo esclude il valore MD5 stampato sulla pagina, gli header/footer e i metadati di impaginazione esterni al relativo blocco di contenuto. Per la pagina dell’indice, gli hash delle pagine precedenti fanno parte del contenuto controllato; il solo hash della pagina indice viene sostituito dal token canonico <SELF> durante il calcolo, evitando una dipendenza circolare.

Pag.	Contenuto	MD5 contenuto
1	Frontespizio e struttura del case study	bf48d621440a4d091c451bdf6b537950
2	Contesto generale del progetto - Project Problem Framing	52b65a2c17ce9fa3dcb4c5d21b1a1f90
3	MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico	b5954ef4571d42f818a58a7ea6b94c8e
4	MR-01 > DEC-MR01-01 - Triage in assenza di immagine	c19a20cb3e6a2573e12b1400241f5e6a
5	MR-01 > DEC-MR01-01 > FR-MR01-01-01 - Continuita’ del triage symptom-only	b338dc964000e7231c5b9c3b1c806439
6	MR-01 > DEC-MR01-02 - Scala di priorit� P1-P4	af4083d56c36fecdc8b8df494b1a71fc
7	MR-01 > DEC-MR01-02 > FR-MR01-02-01 - Dominio della priorit� P1-P4	208463111b8baa856170e9a5f08384e4
8	MR-01 > DEC-MR01-03 - Pipeline analitica a quattro stadi	8a0d041b398e77b0a1cc0678820f8b72
9	MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-01 - Stage 1: urgenza e confidence da immagine	12dbced7963bd0a707b641e0b82762d8
10	MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-02 - Stage 2: descrizione clinica strutturata	7a8a4243407a417e6559f03ffce9e270
11	MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-03 - Stage 3: recupero di casi storici simili	484ce2595a540d51e02906cfb105e8ef
12	MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-04 - Stage 4: sintesi multi-source	9dc575a1a6f95e33f7cef3a8b1a36ffb
13	MR-01 > DEC-MR01-04 - Separazione tra valutazione dell’urgenza e priorit� operativa	b10d2b4e7ef52bd108049be5d03d46aa
14	MR-01 > DEC-MR01-04 > FR-MR01-04-01 - Mapping urgenza/confidence verso P1-P4	3d936b8acb91bd512b0557a4dcf2ca8d
15	MR-02 - Indicazione della destinazione specialistica	bafdb7a8e694cbb9d75b2b2a9400ec27
16	MR-03 - Validazione e correzione medica degli esiti	dfecc41bea68ecf237a07a22b1adda77
17	MR-04 - Adattamento controllato sulla base della revisione clinica	092db6dbf353e4c7e323215976d2e214
18	Indice di integrita delle pagine	8493cb00ad46ac076530d43ec878b19e

Quando una pagina viene modificata intenzionalmente, cambia il suo MD5. Una variazione inattesa segnala una modifica da riesaminare prima di proseguire.